



双相障碍

(躁郁症)

作者: [William Coryell](#), MD, University of Iowa Carver College of Medicine

Reviewed By [Mark Zimmerman](#), MD, South County Psychiatry

已审核/已修订 1月 2026

双相障碍（以前被称为躁狂抑郁症）的特点是抑郁相与躁狂相（或表现为轻度躁狂）交替出现。躁狂主要表现为与外界不相符的过度兴高采烈和自信或身体活动，且患者可能参与危险行为。

- 遗传因素对双相障碍的发病起了一定作用。
- 抑郁相与躁狂相单独或同时存在。
- 患者有 1 段或多段时间出现过度悲伤和对生活失去兴趣，有 1 段或多段时间出现情绪高涨和精力极度旺盛并常伴随易激惹，两者之间可有相对正常的无病期。
- 诊断主要依靠临床表现和症状。
- 使用稳定情绪的药物，如锂盐和一些抗癫痫药物，以及有时进行心理治疗也有一定效果。

双相障碍的名称基于心境障碍中抑郁和躁狂情绪在 2 个极端或极点之间交替。约有 2% 的美国人存在不同程度的双相障碍。在全球范围内，双相障碍的男女患病率相同。发病时间通常在十几岁、20 几岁或 30 几岁时。[儿童双相障碍](#)较为罕见。

大多数双相障碍可归类为

- **双相障碍 I 型：** 患者有至少 1 次躁狂发作（影响了他们的正常社会功能或伴随妄想），并通常伴有抑郁发作。
- **双相障碍 II 型：** 患者曾有过重度抑郁发作，至少 1 次不太严重的躁狂（轻躁狂）发作，但没有躁狂全面发作。

有的患者虽出现类似于双相障碍的发作，但既不符合双相 I 型也不符合双相 II 型障碍的标准。这种发作可归类为待分类的双相障碍或[环性心境障碍](#)。

双相障碍及相关疾病也可能由其他疾病或物质滥用引起。（参见表[躁狂的一些病因](#)以了解更多示例。）

您知道吗.....

- 某些一般疾病、药物和非法药物可导致类似于双相障碍的症状。

(另请参阅[心境障碍概述](#)。)

双相障碍的原因

双相障碍的准确病因不明。据估计，遗传因素在大多数病例中与该疾病的发生发展有关。此外，双相障碍患者体内某些物质（比如神经递质去甲肾上腺素或 5-羟色胺）的调控异常可能也是病因之一。（神经递质是由神经细胞产生的用于信息传递的物质。）

双相障碍起病可能在经历一些应激性生活事件之后，或事件触发一次发作。然而，诱发事件和患病之间的因果关系还未得到证实。

双相障碍的躁狂症状也可因其他原因而发作，例如某些疾病，如甲状腺激素水平增高（[甲状腺功能亢进](#)）。而且，某些药物（如类固醇，有时也称为皮质类固醇或糖皮质激素）或非法药物（如[可卡因](#)和[安非他明](#)）也可导致或诱发躁狂发作。

表格	
诱发躁狂的其他因素	
常见病因	举例
神经系统疾病	脑肿瘤
	头颅外伤
	亨廷顿氏舞蹈病
	多发性硬化症
	影响颞叶的癫痫发作（ 局灶性癫痫发作 ）
结缔组织疾病	中风
	风湿热
	系统性红斑狼疮 （狼疮）
感染	晚期 HIV 感染
	由于某些病毒感染导致的 脑炎
	流行性感冒
	梅毒 （晚期）

常见病因	举例
内分泌系统疾病	甲状腺激素水平高 (甲状腺功能亢进)
药物和非法药物	安非他明类
	某些 抗抑郁药 （包括三环类抗抑郁药和去甲肾上腺素能再摄取抑制剂 [NRIs]）
	Bromocriptine
	可卡因
	皮质类固醇
	左旋多巴

双相障碍的症状

双相障碍常包括情感发作期与无症状期（缓解期）间歇出现。发作持续时间从几周到 6 个月不等。所谓的循环周期是从一次发作到下次发作所经历的时间，时间长短不一。部分患者罕有症状出现，可能终其一生情感发作仅出现数次，然而，还有一些患者可能每年都会有至少 4 次情感发作（被称为快速循环发作）。尽管不同患者症状发作的频次相差甚大，但在同一个患者每次发作的循环周期是基本固定的。

情感发作形式不限，可以是抑郁发作、躁狂发作或轻躁狂。仅有少数患者在每个周期内出现躁狂和抑郁的交替。大多数患者以一种形式为主。

双相障碍患者可能尝试自杀或[自杀](#)死亡。在他们的一生中，他们自杀的可能性是普通人群的至少 20 到 60 倍，高达 20% 的双相障碍患者最终死于自杀。

双相障碍的诊断

- 医生根据标准精神病诊断标准进行评估
- 进行血液和尿液检查以排除其他一般疾病和非法药物使用

双相障碍的诊断基于特定的症状（标准）列表。不过，躁狂症患者可能无法准确报告他们的症状，因为他们不认为自己有任何异常。所以，医生常需要从家人那里获取信息。患者及其家人可使用一种简短的调查问卷评估患者的双相障碍风险（参见[心境障碍调查问卷](#)）。

有时，医生也需要询问患者是否有自杀的想法。

医生会审核患者正在服用的药物，确定它们是否会导致患者的症状。医生也会检查是否有其他一般疾病可导致患者的症状。例如，他们会通过化验血液排除[甲状腺功能亢进](#)，通过化验血液和尿液排除非法药物使用。



视频

通过明确患者处于何种情感发作，即是抑郁发作还是躁狂发作，而决定最佳的治疗方式。他们还评估患者是否有其他精神疾病。

双相障碍的治疗

- 药物
- 心理治疗
- 教育和支持
- 有时还会采用其他治疗方法

重度的躁狂或抑郁常需要住院治疗。即使躁狂症状较轻，一旦患者自杀、试图伤害自己或他人、不能照料自己或有其他严重问题（如[饮酒](#)或其他[物质使用障碍](#)），可能仍需住院。绝大多数轻躁狂患者仅需门诊治疗。快速循环发作患者的治疗难度更大。如果没有得到及时治疗，几乎所有的双相障碍患者都会有症状复发。

治疗的 3 个阶段包括稳定双相障碍的初始症状，达到缓解（症状轻微或无症状的时期），以及维持治疗（防止症状消失后复发）。

特定治疗可能包括

- 心境稳定剂，例如锂和某些抗癫痫药物
- 抗精神病药物，通常是第二代抗精神病药物
- 某些抗抑郁药物
- 心理治疗
- 教育和支持
- 有时[进行电休克治疗](#)、[光疗](#)或经颅磁刺激

(请参阅[治疗双相障碍的药物](#)，以透彻讨论所用药物的类别。)

心理治疗

心理治疗常被推荐用于正在服用心境稳定剂的患者，主要是为了增加他们的服药依从性。

团体治疗可帮助患者及其伴侣或亲友更好的理解双相障碍及其影响。

个别心理治疗则有助于患者学习如何更好的处理日常生活中可能面对的问题。

教育和支持

了解治疗该病的各类药物的作用有助于增加患者对治疗的依从性。患者常拒绝药物治疗，因其觉得药物会影响他们的反应能力和创造性。然而，各种副反应中影响创造性并不常见，因为心境稳定剂使患者情绪稳定，更容易适应工作、学习和各种社会、艺术活动。

患者应学会如何快速识别症状以及如何有效预防情感发作发生。例如，远离各类刺激物（如咖啡因和尼古丁）和酒精，保证充足睡眠。

医师或治疗师应告知患者各种情感发作导致的不良结果。如对于沉迷于纵欲的患者，应告知他们的行为会对恋爱关系造成不良影响和性乱交所带来的健康危害，特别是晚期 HIV 感染的风险。而对于大肆挥霍的患者，应告知其最好将财务交给可信任的家庭成员管理。

家庭成员了解双相障碍并参与治疗提供支持是很重要的。

团体支持治疗可提供一个分享共同经历和感受的平台，以此提供帮助。

其他治疗

电休克治疗（ECT，有时称为“休克治疗”）有时用于治疗难治性抑郁和躁狂。

光疗是指患者观看模拟日光的明亮光线，它可用于治疗季节性（秋冬季抑郁和春夏季轻躁狂）双相障碍，这种障碍与季节性心境障碍或非季节性双相 I 型或双相 II 型障碍有一些共同特征。当用于补充其他治疗时，它的效果可能最好。

经颅磁刺激是指使用设备将无害的磁场施加于头部，用于治疗重度难治性抑郁，也有证据显示它对治疗双相抑郁有效。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[抑郁症和双相障碍支持联盟 \(DBSA\)，双相障碍](#)

[美国心理卫生协会 \(MHA\)，双相障碍](#)

[全国心理疾病联盟 \(NAMI\)，双相障碍](#)

[国家精神卫生研究所 \(NIMH\)，双相障碍](#)